

Paciente: GILCILEY TOMBA DE MOURA
Dr(a): LIA ALVES C SCHINETSKI

Idade: 69 A
Data: 19/07/2025
Protocolo: 2981203

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DAS ARTICULAÇÕES TEMPORO-MANDIBULARES (A.T.M.s.)

TECNICA DO EXAME:

Exame realizado em equipamento de 1,5 Tesla (alto campo). As imagens de ressonância magnética foram obtidas nos planos Coronal e Sagital, na sequência ponderada em DP (densidade de prótons), sendo realizado estudo dinâmico com abertura e fechamento da boca.

RESULTADO (OS SEGUINTE ASPECTOS FORAM OBSERVADOS):

Cavidades glenóide de aspecto anatômico.

Sinais degenerativos nos côndilos mandibulares.

Discos articulares discretamente anteriorizados, com sinais francos de recaptura à manobra de abertura bucal.

Hipoexcursão dos côndilos mandibulares à manobra de abertura bucal.

Discreto derrame articular à direita.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

-Sinais degenerativos nos côndilos mandibulares.

-Discos articulares discretamente anteriorizados, com sinais francos de recaptura à manobra de abertura bucal.

-Hipoexcursão dos côndilos mandibulares à manobra de abertura bucal.

-Demais achados supracitados.

Tomaz A.B. Junqueira

Assinado eletronicamente

Laudado Por:

Dr. Tomaz Aleixo Barboza Junqueira
CRM-SP 142664 / RADIOLOGISTA
CRM-MG 48220 / RQE Nº: 83608

INDICADO POR:

() ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

GILCILEY TOMBA DE MOURA

IDADE: 69 PESO: 69 ALTURA: 158 PROFISSÃO: Restauradora móveis - Após

SINTOMAS: Dor de cabeça (leve para após café) / mmis inchaço
cabeleira.

QUEIXAS: Boca seca / Sono ruim diurna (dorme no volante)

MEDICAMENTOS: zolozok / glifage

Bup p/ parar de fumar

MÉDICO: Dr. Lia (dentista) / Dr. Eduardo Costa

MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N

EXERCÍCIO FÍSICO: Dança particular / Pilates

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: JANTAR: Não

HORA QUE DORME: 22:30 HORA QUE ACORDA: 6:30

COCHILHO ☒ S ☐ N DORME ACOMPANHADO: () S ☒ N () EVENTUALMENTETEM FILHOS: ☒ S () N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA () N às vezes um Gin/Vinho

FUMO: () S () MAÇO/DIA NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: Ex - por 50 anos

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal

BANHEIRO/NOITE: Sa & y / fumante

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não

MALLAMPATI:

IAH: 20.2 SPO2: 84%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Hipotireoidismo / Prolapso da Valv. mitral

Artrite / sinusite / dor lombar

CIRURGIAS: (X) NASAL (S) AMIGDALECTOMIA há muitos anos.

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: PNM de repetição.

JDO: 15.1%

COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA

() NEUROLÓGICA

() OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

04/09/25 Dor cervical que irradia p/ a reg. de escape
da dor e formigamento.
liga TV p/ dormir (calorico / mudo isto ele
cima)

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA BASAL

Nome: GILCILEY TOMBA DE MOURA

Data do Exame: 24-07-2025

Peso: 68 kg

Médico Solicitante: DRA. LIA ALVES DA CUNHA
SCHINETSKI

Sexo: Feminino

Idade: 69 anos

Altura: 1,58 m

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 24/07/2025 21:44 e finalizado às 25/07/2025 05:38.

A latência para início do sono foi de **34,5 min** e a latência para o sono REM de **37,5 min**.

O tempo total de sono (TTS) foi de 412,5 min, com eficiência do sono de **87,6 %**.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **1,2 %** de estágio N1, **51,8 %** de estágio N2, **24,2 %** de estágio N3 e **22,8 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 24,1 min. Ocorreram 16 despertares, sendo o índice de **2,0 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 139, sendo 6 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 133 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **20,2 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 38,3 e o IDR durante o sono NREM foi de 14,9. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 20,2 (nº/h), sendo 0,9 apneia/h e 19,3 hipopneia/h.

A **saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂)** basal foi 93%, a **média** de 91% e a **mínima** de 84%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (**IDO**) foi de 15,1 (nº/h), sendo que em REM foi de **31,9 (nº/h)** e em NREM foi de 13,0 (nº/h). Permaneceu 10,9 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (21), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (**20,2 n°/h**) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (**84%**);
3. Latência para o início do sono (**34,5 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (**37,5 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (**87,6 %**) (VN= $\geq 85\%$);
6. Índice de despertares **2,0 n°/h** (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 (**1,2 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (**51,8 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (**24,2 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (**22,8 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

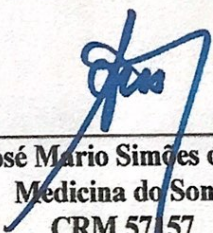
Exame evidenciando Índice de distúrbio respiratório de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.157